Diskussion 638

Datum: 1930-06-03
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 3
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus (doi:10.5281/zenodo.18211787), byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).

Markerade ord: [1] kvinna-ord, [2] släktskaps- och tilltalsord, [3] yrkestitlar.

1. Olof Olsson (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Frågan om det nya kliniska sjukhuset är egentligen ett komplex av frågor, som i det mesta mera lämpa sig för experterna än för oss här. Jag tror därför, att det säkerligen är praktiskt att det, som bör överlämnas åt experterna, inte drages in i diskussionen i dag, utan att vi begränsa oss till sådant, som vi själva begripa och kunna bedöma.

Det råder inte några delade meningar om, huruvida det skall bli ett nytt

kliniskt sjukhus. Det var annorlunda år 1926, när ärendet förra gången diskuterades här i kammaren. Då hade statsutskottet den uppfattningen, att det kanske kunde dragas i tvivelsmål, huruvida man behövde ett så stort sjukhus, och man tänkte sig också, att för den händelse Serafimerlasarettet å ena sidan ändrades och å andra sidan tillbyggdes, skulle detta kanske kunna räcka. I år ligger saken annorlunda. TI år har det gått en bänkagitation för att man borde taga det hela utan några som helst invändningar.

Men eftersom det finns reservationer vid utskottets utlåtande, tyder ju detta på, att det finns delade meningar och att tvist föreligger. VSkalar man bort de onödiga talesätten, finner man, att tvisten egentligen rör kostnaderna. Gör man en jämförelse mellan åren 1926 och 1930, inställa sig ju också omedelbart vissa reflexioner och tvivelsmål, huruvida det är nödvändigt att offra så mycket pengar, som det här är fråga om. År 1926 gällde det 1,154 sängar, och i pengar gällde det 13 miljoner kronor. Meningen var då, att sjukhuset skulle byggas i två etapper, och man ansåg sig därför inte behöva föreslå mer än en mindre summa att hjälpa upp de värsta brister, som vidlådde Serafimerlasarettet. Nu i år gäller det 843 sängar och i pengar ungefär 14 miljoner kronor. Sjukhuset skall dessutom byggas i tre etapper, och under tiden har man — för ett par år sedan — anslagit 3,200,000 kronor till Serafimerlasarettets förbättring. Men år 1926 var såväl departementschefen som statsutskottet och rikedagen på det klara med, att man måste syna de då föreslagna 12 miljonerna lite närmare och se till, huruvida inte besparingar kunde göras. I dag ligger det litet annorlunda till. Nu vill man egentligen att allting skall tagas utan muck. I stort betyder detta, att den åttonde huvudtiteln under de närmaste åren kommer att belastas med en summa för detta sjukhus på 1'/. ä 2 miljoner kronor årligen. Och då man betänker, huru många ärenden som trängas under denna huvudtitel, huru vi sitta och diskutera under timmar några hundratals kronor och ännu längre, om det gäller några tusentals kronor, så förstår man, att alla besparingar äro tacknämliga, om det inte skall bli torka och missväxt på denna huvudtitel. Om det därför är på det sättet, att

det av personer, som förstå dessa ting, framföres anmärkningar, som vi alla något så när kunna bedöma, är det väl inte mer än riktigt, att ärendet går till ny omprövning. Det föreligger ju ett helt knippe av detaljanmärkningar i en motion som väckts i denna kammare. Varken utskottet eller reservanterna anse sig kunna bemästra de där detaljanmärkningarna men ha ändå funnit dem så pass vägande, att man gått in för en överarbetning. Men även på den punkten har utskottet och reservanterna varit oense. Reservanterna anse, att husesynen bör sträcka sig över hela byggnadsföretaget, då däremot utskottet vill, att man skall stanna inför den radioterapeutiska kliniken — ty där har ängelen satt sitt kors.

Emellertid är inte detta kärnpunkten. Den, som har läst utskottets utlåtande, har säkerligen lagt märke till, att egentligen är allting för utskottet ganska gott. Enhetstanken, säger man, är auktoritativt klarlagd, skälen för att man omedelbart skall avgöra frågan äro starka, anmärkningarna, som rikta sig mot byggnadsföretaget, äro utan värde. Samarbetet med Stockholms stad kunde ju visserligen ha varit litet bättre; men bevars, då hade man ju eventuellt måst släppa den där enhetstanken. Och alla de farhågor, som framställts för att

sjukmaterialet inte skulle bliva tillräckligt — alla dessa farhågor äro ogrundade. På det sättet vandrar'utskottet sin väg fram med käcka och spänstiga steg. Men så med ens hejdar man sig och håller handen för ögonen — det är

alldeles, som om man såge en syn. Och så håller utskottet ett litet tal. Det är onekligen så, säger utskottet, att det ur statens synpunkt hade varit önskvärt, om Stockholms stad velat taga i anspråk litet flera vårdplatser, än staden gjort. Och man kan då inte gärna frigöra sig från den tanken, att nya överväganden kunna ge nya resultat. Ja, det är kanske rent av inte uteslutet, att

staden skulle kunna finna med sin fördel förenligt att belägga ytterligare vårdplatser. Och när man nu i alla fall skall gå till en överarbetning, så finns det kanske skäl för att gå till nya förhandlingar med staden.

Detta är egentligen rätt underligt. Och man frågar sig, vad som kan vara orsaken till denna utskottets självbesinning. Personligen misstänker jag, att det sammanhänger med en liten misstanke om just sjukmaterialet. Det är nu nämligen så, att den medicinska undervisningen måste bygga på ett sjukmaterial, som är bättre ju rikhaltigare det är. Jag tänker mig till och med, att för den händelse man tekniskt skulle kunna ordna det på det sättet, att den medicinska undervisningen hade hela Stockholms sjukväsen till sitt förfogande, skulle detta vara idealet. På denna punkt är det emellertid två intressen, som ligga nära varandra. Staten har intresse av ett sjukhus för läkarutbildningen, och staden har intresse av ett sjukhus för sina sjuka. Om dessa båda intressen kunna knytas samman, är det klart, att det bör bli billigare och bättre för båda parterna. Det är egentligen här, som kärnpunkten ligger i den tvist, som råder mellan utskottet och reservanterna.

Men innan jag går litet vidlyftigare in på detta, vill jag liksom lyfta ur vägen en sten, som ligger och hindrar, nämligen den s. k. enhetstanken. Man säger, att det är den springande punkten. Om inte denna genomföres, då är hela företaget värdelöst eller förfelat. Egentligen visar sig denna enhetsanke i två skepnader. Å ena sidan säger man, att de olika undervisningsklinikerna inte kunna ligga spridda, såsom nu en lång tid varit fallet, utan att de måste sammanföras för att kunna hjälpa varandra, och å andra sidan säger man, att de teoretiska institutionerna spela en bestämd roll i samarbetet och följaktligen också måste ligga i närheten av de praktiska klinikerna. Det är uppenbart, att enhetstankens räckvidd i detta fall har en stor betydelse. Om det nämligen är på det sättet, att allt, som kan räknas till Karolinska institutet — rubb och stubb —, behöver vara på ett och samma ställe, då är det klart, att byggnadsfrågan inte bara måste försvåras utan också fördyras.

Som lekman har jag ingen mening om detta, i varje fall ingen rotfästad mening, men jag gör ett par reflexioner. Jag förstår mycket väl, att man behöver ett komplex av kliniker, att de medicinska och kirurgiska klinikerna behöva varandra och att de och specialklinikerna kunna ha gagn av varandra. Men jag förstår däremot inte, att två medicinska och två kirurgiska kliniker nödvändigt skola ligga vid sidan av varandra, och jag förstår det så mycket mindre som Karolinska institutets lärarkollegium har förklarat, att den obstetrisk-gynekologiska kliniken, som ligger å Allmänna barnbördshuset, inte behöver flyttas, därför att den ju har moderna och bra lokaler. Jag förstår också, att vissa av de teoretiska institutionerna kunna spela en roll i samarbetet, men jag tvivlar på, att alla spela den rollen, och jag tvivlar på detta så mycket mera, som många läkare, som jag har talat med, inte bara svävat på målet utan också ställt sig rätt skeptiska.

Men jag gör också en annan reflexion. Om det är på det sättet, att denna enhetstanke spelar en avgörande roll vid den svenska läkarutbildningen, hur är det då egentligen ställt nu med denna utbildning, och hur blir det ställt inom den närmaste framtiden? Det är nämligen rätt länge sedan enhetstanken kunde göra sig gällande, och det blir åtminstone ett 20- eller 30-tal år framåt i tiden, som den heller inte kommer att spela någon synnerligen stor roll. Jag menar också, att enhetstanken är en mänsklig företeelse. Den kan inte vara heligare den än annat världsligt. Man bör väl ha rätt att tvivla, om ett samarbete är nödvändigt mellan allt som man räknar till Karolinska institutet och huruvida det också är nödvändigt, att allt detta skall ligga på samma tomtområde. Man kan ha rätt att tvivla, och man kan ha rätt att begära en undersökning. Om det visar sig, att det är nödvändigt, så måste man ju böja

sig. Men om det skulle visa sig, att det inte är absolut nödvändigt, att det i visst avseende skulle vara bra eller dylikt, då tycker jag, att det är oriktigt, att denna enhetstanke — driven till det yttersta — skall stå i vägen för en praktisk lösning av det spörsmål, som nu föreligger.

Men efter denna utvikning skall jag be att få återvända till själva ärendet. År 1926 föreslogs de allmänna sängarnas antal till 1,019 stycken. Av dessa skulle Stockholms stad och Stockholms län ta i bruk 700 stycken. TI år äro de allmänna sängarna inte mer än 729, och av

dessa ha Stockholms stad och län endast velat ta i bruk 425. Det är inte mycket. Men genom att bygga dyra sängplatser för riket, om jag så får säga, och lika dyra för garnisonen. har man i alla fall fått ett något så när stort sjukhus. Men detta är bara den första etappen med de sex klinikerna och några andra anstalter. En gång skall Serafimerlasarettets kliniker också flytta hit. Vem skall då belägga platserna? Att det blir sjuka behöva vi inte frukta, men vem skall betala sängarna? Tänker man sig, att staden skall göra det? I det fallet har man inte mycket att hoppas, ty stadskollegiet och med detta stadsfullmäktige ha förklarat, att de inte vilja göra någon som helst utfästelse på denna punkt. De ha tagit på sig de 315 sängar, som det gäller nu i första etappen, men de förbinda sig inte att deltaga i en framtida utbyggnad. Och jag förmodar, att det är just detta, som gjort, att utskottet slagit sig för pannan och hållit det lilla talet om de fortsatta förhandlingarna. Ty när Karolinska sjukhusets första etapp står klar, har staden ett stort sjukhus på Söder och kanske också ett stort sjukhus på Norr. Ungefär 600 meter söder om Norrbacka ligger nämligen Sabbatsbergs sjukhus. Det är bekant för utskottet, att man tänker bygga ut detta till en kapacitet på över 1,000 sängar — jag vågar inte säga mera, men det är möjligt, att det blir halvtannat tusen. Är det verkligen rimligt, frågar jag mig, att staten skall bygga ett sjukhus på Norrbacka, och 600 meter söder om Norrbacka skall det byggas ut ett nytt, stort stadens sjukhus på Sabbatsbergsområdet? Det är detta, som egentligen är problemet för oss här i dag, och det är detta problem, som gjort, att även utskottet har glidit in på de tankegångar, som utskottsreservanterna representera. ;

Vad är det nämligen, som reservanterna vilja? Jo, reservanterna säga ungefär så här: Det bör inte få hända, om det kan förhindras, att staten och staden bygga var sitt sjukhus så nära intill varandra. När vi veta, hur det ligger till, så skola vi inte handla, som om vi ingenting visste. Det är därför inte rätt att bestämma sig nu. Tvärt. Ty då är allting förkylt. Det är väl bättre att i stället se efter, huruvida inte ett samarbete kan äga rum i den trakten. Det kan ju hända, att staten kan ha nytta av Sabbatsberg, och det kan ju också hända, att staden kan ha nytta av Norrbacka — antingen på det sättet, att staden bygger och staten hyr eller så, att staten bygger och staden hyr. Man kan väl åtminstone pröva den saken. Förslaget, som ligger på bordet, har ju inte fallit ifrån himmelen. Det är ju vanliga dödliga människor, som framlagt det, och man bör väl då kunna ha lov att pröva det.

På detta svarar utskottet, att staten aldrig någonsin kan ha någon nytta av Sabbatsberg. Det är uteslutet. Utskottet har undersökt möjligheterna ett inom staden få tag i någon stadens sjukhustomt, som skulle kunna vara tillräckligt stor. Men inte ens om man läte de teoretiska institutionerna ligga för sig, skulle man kunna finna någon tomt, som skulle räcka för klinikerna jämte de byggnader, som höra tillsammans med dessa. Men Norrbacka, däremot, säger man, det kan väl passa. Skulle inte möjligen Sabbatsberg kunna flytta till Norrbacka? Skulle inte staden kunna finna det ekonomiskt att göra på det sättet? Och när nu saken 1 alla fall skall gå till omprövning, kanske det är skäl att inbjuda Stockholm till förhandling. Men bara till förhandling om detta, ty utskottet är fullt på det klara

med, att vi måste ha ett orygglgt beslut i år om att Norrbackaområdet skall användas.

Det där, som utskottet säger om »undersökningarna», är en lustig omskrivning. Ett par stycken av statsutskottets representanter och ett par stycken av reservanterna ha nämligen traskat omkring på Sabbatsbergstomtens område. Det är alltsammans. Och jag får ju säga, att det är att ge det ett väl vackert namn, att kalla detta för »undersökning». Nej, om Sabbatsberg veta vi faktiskt ingenting, lika litet som vi veta någonting om de andra tomterna. Men jag kan inte förstå, varför man inte skulle kunna undersöka saken. Om det är så, att det visar sig omöjligt, då vet man ju det. Skulle det finnas möjlighet till ett samarbete, då är det väl oriktigt att avböja detta av den rena okunnigheten, som det ju blir i detta fall. Men för övrigt finns det en bestämd skillnad emellan utskottets förslag och reservanternas. Reservanterna vilja, att man skall pröva alla möjligheter utan några som helst förutfattade meningar. Går det, så går det. Går det inte, så kan ju ingen människa hjälpa det. Man har då i alla fall gjort ett försök. Utskottet vill däremot, att man vid denna undersökning bara skall sysselsätta sig med en enda sak. Stockholms stad skall få tillfälle att ångra sig. Staden har förut förklarat, att man inte har några intressen på Norrbackaområdet, men nu skall Stockholm få tillfälle att säga, att man har det. Jag måste ju säga mig, att inte är detta något vidare försynt förslag, och inte kan man heller säga, att det har några hoppfulla perspektiv. Men det är en sak, som jag tycker är värre i det förslaget, och det är, att det ger sken av förhandlingar utan att egentligen vara det. Man vill liksom kunna säga, att man har gjort allting, som kan göras, och skulle det inte gå — nå bevars, då är det i varje fall inte statens fel. I grund och botten är utskottets förslag inte någonting annat än ett bifall till Kungl. Maj:ts med ett litet kuriöst teaterspel, som tycks ha lurat utskottet men som säkerligen inte lurar någon annan.

Emellertid har det bedrivits en — man kan säga — ganska ordentlig agitation i detta ärende. Jag tänker mig, att kammarens olika ledamöter har haft mer 'än känning av den. Den journalistiska agitationen driver den satsen, att utskottets förslag löser frågan i år, då däremot reservanternas förslag — ja, det är egentligen ingenting annat än ett avslag, som kastar ut frågan i nya vidlyftigheter. Saken är ju den, att både reservanterna och utskottet gå på uppskovslinjen, fastän utskottet binder framtiden. Ty vad är egentligen skillnaden mellan utskottets s. k. omedelbara lösning av frågan nu jämte förhandlingar och reservanternas uppskovsyrkande? Om vi gå reservanternas väg, vad är det då som händer? Jo, antingen kommer man underfund med att något samarbete inte är möjligt. Då går man fram med Kungl. Maj:ts förslag. Det förefaller mig, som om den saken skulle kunna avgöras jämförelsevis snabbt. Eller också kommer man underfund med att ett samarbete är möjligt. Då blir det nya rilningar o. s. v., och då måste man ånyo gå till stadsfullmäktige och till riksdagen. Vad är det som händer, om man går utskottets väg? Jo, antingen blir det så, att staden säger nej, och då går man 1 det fallet också fram med Kungl. Maj:ts förslag. Eller också blir det på det viset, att staden svarar ja. Då blir det nya ritningar o. s. v., och så blir det att på nytt gå till stadsfullmäktige och till riksdagen. Jag kan inte se, att det finns någon större skillnad emellan dessa båda olika ståndpunkter, när de gå till aktion. Men jag tycker ju, och med mig de övriga reservanterna, att när förhandlingar i alla fall skola ske, då kan man

likasåväl reservera åt sig så många möjligheter, som äro tänkbara. Blir det avslag, bör det kunna gå lika raskt i det ena fallet som i det andra. Blir det bifall — då är väl detta värt dröjsmålet.

Men det har bedrivits en annan agitation, som gått fram med större trum-

mor² — om jag så får säga — och som sökt samla de mera sentimentala. Det är ju så, att vi ha någonting, som kallas för radiologi. Den måste knytas till ett större kliniskt sjukhus, har man sagt, det är dess livsvillkor. Det viktigaste och det allra viktigaste medlet, då det gäller kräftsjukdomarnas bekämpande, är den tidiga diagnosen, säger man vidare, och radioterapeuten måste därför vara i ständig förbindelse med de andra medicinmännen, med fackspe-

cialisterna i kirurgi, gynekologi o. s. v. Tänk därföre — tänk därföre på de kräftsjuka! Tänk på hela landets kräftsjuka och dröj inte med detta rikssjukhus!

Detta är en rätt försåtlig agitation, som naturligtvis fångar en hel del. Om det varit på det sättet, att frågan gällt sjukhus eller inte sjukhus, då kunde jag finna den agitationen förståelig, men det gäller inte detta i närvarande stund. Vad det gäller är en liten frist att tänka över, hur man bäst och billigast skall kunna ordna denna sak. Ty det är visserligen sant, att tiden är dyrbar, men pengar äro också dyra, och vad som inte går åt för att möta det ena lidandet, kan kanhända behövas för att möta det andra. Radioterapien har sin begränsning, men lidandet tycks inte ha det, om man får döma av vad man ser och hör här i världen.

Jag tror för min del, att om man inte blundar och inte fantiserar utan ser saken rätt i ögonen, finns det ingenting av värde, som kommer att äventyras, för den händelse man går reservanternas väg. Ingen kan säga med rätta, att reservanternas förslag är att kasta ut ärendet i nya äventyrligheter. Men går man utskottets väg, då skär man av den möjlighet — som kanske finnes, kanske också inte finnes men som bör undersökas — den möjligheten nämligen att skapa mellan staden och staten ett samarbete, som kan vara båda parterna till båtnad. .

Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

2. Olof Bergqvist (Högerns riksdagsgrupp, man)

Herr talman! Man behöver i denna diskussion icke upptaga frågan om behovet av nybyggnader för Karolinska institutet, ty detta är så klart ådagalagt, att ingen förnekar detsamma. Den föregående ärade talaren har också för sin del bekräftat, att ett oavvisligt behov i detta avseende föreligger. Man måste sålunda utgå ifrån den förutsättningen, att det är nödvändigt, att åtgärder vidtagas för att bereda detta institut tidsenligare lokaler, som det behöver för sitt arbete. Men när man tänker över detta problem, måste man givetvis göra klart för sig vad som bör vara det framför allt bestämmande i byggnadsfrågan. Det är visserligen sant, att frågan om kostnaderna därvidlag spelar en betydande roll, men man får

dock icke göra kostnadsfrågan till den primära och ensamt avgörande, utan vad man framför allt måste se på, det är ändamålsenligheten, att sålunda den nya anstalt, som man grundlägger, kommer att motsvara det ändamål, den är avsedd att tjäna, och detta för en lång tid framåt.

Till denna ändamålsenlighet har räknats såsom en viktig faktor, att alla kliniker jämte de teoretiska institutionerna kunna sammanföras till en och samma plats, där de kunna utan tidsutdräkt och andra hinder samarbeta på bästa sätt med varandra. Denna s. k. enhetstanke är enhälligt förordad av alla representanter för Karolinska institutet. Även de, som i ett eller annat avseende intagit en särställning i vissa frågor, äro dock av den uppfattningen, att det är önskvärt, att denna enhet mellan klinikerna och de teoretiska institutionerna kan genomföras, och de allra flesta äro av den uppfattningen, att det är nödvändigt. Riksdagen har också själv godtagit denna uppfattning. Vid de beslut, som förut här äro fattade, har riksdagen utgått ifrån att det skall bli en enhetlig komplex av byggnader för den medicinska undervisningen

här i Stockholm. När 1927 års riksdag beslöt att upplåta Norrbackatomten för institutet, låg just denna enhetstanke bakom detta.

Nu ha emellertid reservanterna dragit i tvivelsmål, huruvida denna tanke i själva verket är så oantastlig. Man har menat, att det med nutida kommunikationer nog skulle låta sig göra att på ett ändamålsenligt sätt anordna undervisningen vid institutet, utan att man behövde ha alla kliniker och teoretiska institutioner på samma plats. Den föregående ärade talaren har ägnat en stor del av sitt anförande just åt att bevisa detta, och han har sagt, att det bör vara tillåtet för en lekman att tvivla på nödvändigheten av enhetstanken. Jag undrar, om inte herr Olsson genom dessa uttalanden kom något litet i strid med själva utgångspunkten i sitt anförande, där han sade, att vi skola lämna å sido allt, som experterna böra få avgöra, och endast sysselsätta oss med det tekniska. Här tror jag just är en punkt, där experterna böra ha ett avgörande ord, ty det är de, som bäst inse, vilken betydelse det har, att de olika grenarna av undervisningen kunna lätt samarbeta med varandra.

Jag för min del måste sålunda utgå ifrån att det finns fullt fog för den från sakkunnigt håll nästan enhälligt uttalade tanken, att institutionerna böra ligga på samma plats. Jag utgår ifrån att detta är riktigt och att det skulle inskränka ändamålsenligheten av anstalterna, därest de icke vore förlagda till samma ställe. Men om nu denna tanke verkligen är riktig, bör man vid frågans lösning fästa avseende vid densamma, och då tror jag knappast, att man kan gå den väg, som reservanterna förordat. Det är nog nödvändigt, att institutet med kliniker förblir en statsinstitution framdeles såsom hittills. Att tänka sig, att Stockholms stad skulle övertaga byggandet av klinikerna och bli byggherre, tror jag knappast kan vara en väg, som är framkomlig. Först och främst vore det, om man tänkte sig möjligheten av att staten så att säga skulle hyra in sig på något av Stockholms nuvarande sjukhus, t. ex. Sabbatsberg, alldeles avgjort, att icke den enhet kunde genomföras, om vilken här talats. Den tomt, som Sabbatsberg förfogar över, är för liten, något som t. o. m. herr Olof Olsson erkände. Det har

visserligen sagts, att om man bygger sjukhuspaviljonger på nio eller tio våningar och låter de teoretiska institutionerna växa ännu mer i höjden, man möjligen skulle kunna få plats på Sabbatsberg för det Karolinska institutet med kliniker. Men mot ett sådant byggnadssätt reses hinder från brandsäkerhetssynpunkt; särskilt klinikerna kan man icke inrymma i så höga byggnader. Därför har nog den tanken övergivits även av reservanterna, att det skulle vara möjligt att genomföra någon enhetlig institution på Sabbatsberg.

Men så har man kommit på en annan tanke, nämligen att staden helt enkelt skulle nedlägga Sabbatsberg och i stället bygga ett stort sjukhus på Norrbacka, där då Karolinska institutet skulle få bedriva sin kliniska undervisning. Denna tanke förefaller onekligen något äventyrlig. Norrbacka ligger, om jag icke misstager mig, utanför Stockholms hank och stör, och det är väl inte troligt, att Stockholms stad vill bygga en stor sjukvårdsanstalt utanför sitt eget område. Men om man i alla fall skulle kunna tänka sig, att detta kunde ske, skulle det kräva långa förhandlingar och dra ut i det oändliga på tiden. Man skulle nödgas träffa nya uppgörelser, som måste underställas stadsfullmäktige och andra stadens myndigheter, och det skulle utarbetas nya ritningar, beträffande vilka Stockholms stad givetvis ensam måste få bestämma. Sjukhuset komme förmodligen också att få mycket större dimensioner, än vad nu är avsett. Allt detta skulle sedermera behandlas i olika instanser genom remisser hit och dit, och innan ärendet kunde komma tillbaks till riksdagen, skulle många år ha förflutit. Jag har mottagit en promemoria, däri det i detalj bevisats, att en förhandling i sådan riktning skulle åtminstone

räcka fyra år framåt innan allt vore färdigt att föreläggas riksdagen. När vi veta, hur det Karolinska institutet för närvarande har det ställt, bör man icke vidtaga åtgärder, varigenom lösningen av frågan om nybyggnaderna skjutes långt fram i tiden. Nu äro ju klinikerna spridda här och var i otidsenliga lokaler, och föreläsningarna få hållas i korridorer på sina ställen, eller åtminstone i mycket provisoriska lokaler, så trånga, att studenterna knappast ens få rum. Detta förhållande kan ju icke få fortgå så synnerligen länge, utan det blir nödvändigt, att riksdagen vidtager åtgärder för att så snart som möjligt avhjälpa dessa brister.

Jag tror för min del icke heller, att den påtänkta underhandlingen om att staden skulle bli byggherre komme att leda till något resultat. Men om så skedde, komme det i allt fall, som sagt, att skjuta frågans lösning långt framåt i tiden. Beträffande däremot underhandlingar med staden om att den eventuellt ville övertaga ett större antal sjukvårdsplatser på Norrbacka, finnes den tanken även i utskottets förslag. I detta avseende står utskottet på samma linje som ett av reservanternas alternativ. Det är en underhandling, som kan göras under året, och som inte behöver på något sätt förhindra arbetets fortgång. Förberedelserna kunna ostört ske, ty om staden tar flera eller färre av sjukvårdsplatserna för sin del, innebär detta icke någon rubbning i själva programmet för byggnaderna. Dessa förhandlingar kunna slutföras under det år, som nu kommer, och nästa riksdag kan ge det anslag, som behövs för byggnadernas påbörjande.

Vad som sagts om sjukmaterialet, d. v. s. den uttalade farhågan att det icke skulle finnas några säkra utsikter att få ett rikhaltigt sjukmaterial i ett sjukhus på Norrbacka, särskilt om Sabbatsberg, som ligger i dess närhet, fortfarande är i verksamhet, tror jag inte mycket på. Det är i varje fall ett antagande, och det torde kunna anses tämligen säkert, att erfarenheten kommer att fullständigt jäva detta antagande. Sjuka finns det alltid, och till ett sjukhus av den kvalitet som Norrbackasjukhuset skulle utan tvivel patienter med största förtroende söka sig. Jag tror följaktligen icke, att denna farhåga bör tagas på något större allvar.

Så är det då frågan om kostnaderna. Det är klart, att man ryggar tillbaka för en kostnad på 24 miljoner kronor, av vilka staten skall betala 14 miljoner, och detta för endast den första etappen. Men vi skola icke tro, att staten undkommer kostnaderna genom att göra ett uppskov. Det kan måhända bli någon mindre väsentlig modifikation i kostnaderna, det vill jag inte förneka, men 1 så fall blir det utan tvivel på bekostnad av ändamålsenligheten. Den första etappen av byggnadsarbetet skulle utföras på 8 byggnadsår; de 14 miljonerna i anslag från statens sida skulle portioneras ut på 8 byggnadsår på så sätt, att anslaget skulle bli något över 2 miljoner kronor de flesta åren — första året mindre och sista året också mindre. Det blir sålunda icke en utgift på en gång, utan den får som sagt göras efter hand under dessa 8 byggnadsår.

Så ha vi de två återstående byggnadsetapperna, och man måste ju även tänka på de kostnader, som dessa komma att medföra. Någon utredning om vad det kommer att kosta att överflytta de kliniker, som icke komma med i första etappen, samt Karolinska institutets teoretiska institutioner till Norrbacka, föreligger icke. Jag har emellertid mottagit en beräkning av en sakkunnig person, och enligt denna skulle kostnaderna för dessa båda etapper gå till ungefär 18 miljoner kronor. Emellertid har man beräknat, att staten skulle få sälja tomterna nere vid Serafimerlasarettet och Karolinska institutet m. m., och värdet av dessa tomter är beräknat till ett belopp av mellan 17 och 18 miljoner kronor. Skillnaden mellan vad det kostar att bygga i de båda övriga etapperna och vad man kan beräkna att få för de tomter, som man får till disposition, är följaktligen ytterst ringa.

Jag tror därför, att man icke behöver synnerligen mycket befatta sig med farhågorna för de två senare etapperna — den största bördan blir naturligtvis den första.

Beträffande våra statsutgifter undrar jag, om man inte med skäl kan fråga sig, huruvida det överhuvud taget finns några viktigare och angelägnare än de, som avse att vårda folkets hälsa, däri inberäknade utgifter, som avse att utbilda skickliga läkare. Om en enskild person blir sjuk, så att han riskerar sin hälsa eller sitt liv, då frågar han inte i första hand efter vad det kostar, utan han frågar, var han skall finna hjälpen, och sedan kommer kostnadsfrågan i andra hand. Det förefaller mig, som om riksdagen hade anledning att tänka ungefär på samma sätt, när det gäller det ärende, som vi nu diskutera. Naturligtvis måste staten alltid se till, att den inte tar på sig större bördor än den kan bära. Men ingen kan väl påstå att, om än detta sjukhus kommer att kosta stora summor, denna utgift likväl överstiger den svenska statens

förmåga att bära. Få vi här i Stockholm en ändamålsenlig anstalt för utbildning av läkare, har detta en oändligt stor betydelse för vår folkhälsa. Jag tänker därför, att även om den ekonomiska bördan blir tung vi dock alla måste finna, att detta är ett ändamål, för vilket vi böra offra, vad vi kunna.

Jag skall nu icke längre upptaga kammarens tid, utan jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

3. Carl Gustaf Hammarskjöld (Första kammarens nationella parti, man)

Herr talman! Då jag fogat en blank reservation till statsutskottets betänkande, anhåller jag att få yttra några ord i frågan.

Statsutskottet hemställer, att riksdagen måtte i princip godkänna det i propositionen framställda förslaget, d. v. s. att till Norrbackaområdet skall förläggas icke blott det nya Karolinska sjukhuset utan även nya lokaler för det Karolinska institutets teoretiska institutioner, och att för dessa ändamål vissa förberedelser omedelbart skola vidtagas. Utskottet anhåller likväl om utredning i tvenne punkter. Utskottet hemställer sålunda om en överarbetning av det i princip godkända förslaget för att om möjligt nedbringa kostnaderna, samt att om nya förhandlingar med Stockholms stad rörande samarbete för sjukhusets uppförande och drift i syfte att staden må å sjukhuset belägga ett större antal platser än enligt det nu förevarande avtalsförslaget, och att nytt förslag härutinnan måtte framläggas till nästkommande riksdag. I sammanhang härmed har emellertid utskottet hemställt, att det nuvarande garnisonssjukhuset i Stockholm »skall sammanslås med Karolinska sjukhuset i huvudsaklig överensstämmelse med de allmänna grunder, som av chefen för försvarsdepartementet i statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden den 14 mars 1930 förordats».

Det är om denna sista punkt jag anhåller att få yttra några ord.

Det föreslagna Karolinska sjukhuset företer vissa principiella skiljaktigheter från flertalet övriga sjukhus. När man skall bygga ett sjukhus, beräknar man i allmänhet antalet allmänna vårdplatser med hänsyn till det sjukområde, för vilket sjukhuset är avsett, och det antal vårdplatser, som med hänsyn härtill kan behövas. När det gäller det Karolinska sjukhuset återigen, uppställer man ett minimiantal av allmänna vårdplatser, men detta är beräknat icke med hänsyn till ett visst förut givet sjukklientel, utan med hänsyn till det sjukklientel, vilket anses erforderligt med hänsyn till den medicinska högskolans undervisning.

Då i förra veckan statsutskottets utlåtande angående **flickskolorna²** var före här i kammaren, yttrade samme talare, som i dag inledde debatten, att **flickorna²** icke voro till för **flickskolornas²** skull utan att dessa skolor voro till för **flickornas²** skull. På samma sätt kan man nog i regel säga, att de sjuka icke äro till

för sjukhusens skull, utan sjukhusen för de sjukas skull. Men när det gäller Karolinska

sjukhuset, kan man måhända icke med samma rätt fälla detta yttrande, ty detta sjukhus måste nämligen under alla förhållanden förfoga över ett minsta antal allmänna vårdplatser, för att den avsedda undervisningen skall kunna bedrivas. På sjukhusets storlek inverkar därför icke frågan om garnisionssjukhusets förläggning dit eller icke. Vare sig garnisonssjukhuset förlägges dit eller icke, måste nämligen sjukhuset ha samma storlek, som här är föreslaget, och om icke vissa av de angivna allmänna vårdplatserna fyllas från Stockholms garnison, måste helt enkelt patienter anskaffas på annat sätt.

Av vad jag nu anfört torde framgå, att frågan om garnisonssjukhuset i Stockholm i framtiden rätteligen icke bör sammankopplas med det Karolinska sjukhusets byggnadsfråga utan med den fråga, med vilken den verkligen har sammanhang, nämligen frågan om hur man skall anskaffa klientel till detta sjukhus. Då nu utskottet föreslår, att nya förhandlingar skola upptagas med Stockholms stad i syfte att belägga ett större antal platser på sjukhuset med patienter från Stockholms stad, följer härav, att man till nästa års riksdag skall lämna öppen frågan om garnisonssjukhusets ställning. Jag anser nämligen, att om man skall gå till en dylik underhandling med Stockholms stad, bör man inte vara bunden, utan det är en logisk nödvändighet, att man håller denna fråga öppen, så att man med Stockholms stad verkligen kan underhandla angående samtliga vårdplatser på det Karolinska sjukhuset.

Hittills har jag betraktat frågan uteslutande ur det Karolinska sjukhusets synpunkt. Jag anhåller emellertid att få i största allmänhet anföra några principer även ur garnisonssjukhusets synpunkt. Jag vill då först hänvisa till de svar, som avgivits på remissen från försvarsdepartementet och som finnas återgivna i den kungl. propositionen på sidan 126. Därav framgår, att alla de militära myndigheter, som yttrat sig i frågan, utom arméförvaltningen och chefen för östra arméfördelningen, yrkat avslag. Starka betänkligheter äro framförda av medicinalstyrelsen. Vad chefen för östra arméfördelningen beträffar, måste jag ett ögonblick dröja vid hans yttrande. Det har framställts tre förslag till ordnande av garnisonssjukhuset. Det ena var att anordna sjukhuset som ett fullt fristående sjukhus, antingen på den nuvarande tomten eller på någon annan plats. Det andra förslaget var att bygga en särskild paviljong på Norrbackaområdet för detta sjukhus, men i så måtto ansluta det till Karolinska sjukhuset, att det skulle ha gemensam förvaltning och gemensam värmecentral. Även i övriga avseenden borde ett visst samarbete förutsättas. Det tredje förslaget var att helt och hållet införliva garnisonssjukhuset med det Karolinska sjukhuset och att lägga in patienterna från garnisonen på det Karolinska sjukhusets kliniker. Vad säger nu chefen för östra arméfördelningen? Jo, han finner, att det första förslaget om ett fullständigt självständigt sjukhus är det lämpligaste, men han utmönstrar detta av ekonomiska skäl. Han övergår sålunda till att förorda samarbete med det Karolinska sjukhuset, men anser i det fallet, att det vore önskvärt, att detta kunde ske genom att för garnisonssjukhuset anordnades en fristående paviljong. När han sålunda förordar propositionens av sjukvårdssakkunniga framförda förslag, har han dock bland de olika möjligheterna att lösa denna fråga faktiskt ställt detta förslag 1 tredje rummet.

Vad arméförvaltningen beträffar, har denna helt tillstyrkt det föreliggande förslaget. Men arméförvaltningen har även påpekat, att ett antal frågor finnas av för fjärde huvudtiteln ekonomisk räckvidd, som i betänkandet lämnats öppna, och sedan dessa frågor angivits, yttrar arméförvaltningen: »Nu berörda frågor kunna säkerligen för försvarsväsendets vidkommande medföra konsekvenser, som svårligen låta sig för närvarande överskåda. Arméförvaltningen förutsätter emellertid, att dessa frågor komma att bliva föremål för

fullständig och sakkunnig utredning i god tid, innan sjukhuset må komma att tagas i bruk.»

Detta är alldeles riktigt. Men det är en gammal god regel, att när man skall fatta beslut, särskilt i en organisationsfråga, är det åtminstone önskvärt, om icke nödvändigt, att man vid beslutets fattande vet vilka ekonomiska konsekvenser beslutet får. Om man nu uppskjuter beslutet till 1931 års riksdag, då efter statsutskottets utlåtande definitivt avgörande i denna fråga skall äga rum, torde det icke vara omöjligt att till dess verkställa den här åsyftade ekonomiska utredningen. Och vad särskilt den av riksdagens båda kamrar begärda utredningen i försvarsfrågan beträffar, torde det vara av vikt, att dessa ekonomiska spörsmål komma att bli utredda så hastigt som möjligt, ty såsom kammaren torde erinra sig, intogo i beslutet om skrivelse de ekonomiska synpunkterna en mycket framskjuten plats.

Jag skall slutligen anföra ett par yttranden angående de principiella synpunkterna beträffande den föreslagna anslutningen. Jag ber att först få anföra vad professorerna Hedrén, Forssell och Key yttrat till sjukhuskommissionen i vad det gäller frågan om institutets ändamål. De säga: »Det måste därför, med hänsyn till institutets ändamål, vara till institutets nackdel, därest med institutets verksamhet införlivas övriga uppgifter, som tillhöra garnisonssjukhuset, men som icke hava samband med vetenskaplig forskning och undervisning. Motsvarande synpunkter torde, om ock i mindre grad, kunna anses giltiga, därest garnisonssjukhusets sammanslagning med det kliniska sjukhuset betraktas från uteslutande militär synpunkt, ur vilken ett eget självständigt sjukhus torde bäst tillgodose militära krav.»

Jag skall i den ganska rikhaltiga samling av yttranden endast anföra ytterligare ett, nämligen det, som är avgivet av Karolinska institutets lärarkollegium. Lärarkollegiet anför följande: »Det synes emellertid uppenbart, att en sammankoppling av civila och militära intressen, som här skulle bliva fallet, kan giva anledning till kollisioner, vilka kunna komma att inverka i hög grad störande på sjukhusets verksamhet. Med de anspråk på disciplinär myndighet över de sjuka, som från militär sida uppställas, synes det bliva svårt att uppdraga gränsen för befogenheterna emellan å ena sidan militärmyndigheterna och å andra sidan den civila sjukhusledningen.»

Av dessa båda yttranden torde framgå, att även ur medicinsk synpunkt ganska goda skäl kunna anföras för att, när ändå frågan 1 sin helhet skall uppskjutas ett år, taga dessa spörsmål under förnyat övervägande. Omedelbart före sist anförda yttrande uttalar Karolinska institutets lärarkollegium följande märkliga ord: »Det militära klientelet är visserligen genom

en viss ensidighet ej likvärdigt med övrigt klientel, men är dock användbart för den mediecinska undervisningen.»

Sålunda har Karolinska institutets lärarkollegium förklarat, att det militära klientelet icke är likvärdigt med annat klientel. Kunde kollegiet till nästa år ställas inför valet att antingen taga hela klientelet från Stockholms stad och Stockholms län och riket i övrigt med uteslutande av garnisonen, eller att taga en del av klientelet från garnisonen, torde man icke behöva stanna i tvivelsmål om hur detta val skulle utfalla.

När nu fråga är att upptaga underhandling med Stockholms stad för att skaffa ett större klientel från staden, bör man väl icke, genom ett beslut i dag, avskära möjligheter, att fylla klientelet i dess helhet med ur Karolinska lärarkollegiets synpunkt fullgott material.

På grund av vad jag nu har yttrat skall jag framkomma med ett särskilt yrkande. Det ansluter sig i allt väsentligt till statsutskottets utlåtande, så att jag i fråga om statsutskottets hemställan endast i en enda punkt önskar en ändring. Jag hemställer nämligen, att punkten 2) under I. måtte utgå, och

att naturligtvis i samband därmed punkten 3) erhåller nr 2. I fråga om motiveringen nödgas jag påyrka två ändringar. Den ena gäller utskottets yttrande på sidorna 35 och 36, där jag anhåller, att det stycke, som börjar längst ned på sidan 35: »En ytterligare omständighet, som synes utesluta möjligheten av» 0. s. v., och som slutar överst på nästa sida med orden: »D. v. s. de speciellt militära och undervisningens, som ock samtidigt kommunens intressen kunde i tillbörlig grad tillgodoses», måtte helt utgå. Slutligen hemställer jag, att i utskottets motivering i sista stycket på sidan 38, på sjunde raden nedifrån, efter den mening, som slutar med orden »så att bägge dessa frågor kunde samtidigt på nytt föreläggas 1931 års riksdag», måtte tillkomma en ny mening av följande lydelse: »I sammanhang härmed bör av naturliga skäl garnisonssjukhusfrågan upptagas till nytt övervägande.»

Detta av mig framställda förslag är sålunda icke revolutionerande, utan det åsyftar endast att få statsutskottets förslag bättre anpassat såväl med hänsyn till det Karolinska sjukhusets som garnisonssjukhusets verkliga behov. Skulle jag icke vinna gehör för detta mitt yrkande, nödgas jag, med den syn jag har på denna fråga, förena mig med den reservation, som är avgiven av herr Lind-